

Programas de salud prioritarios: infantil, adolescente, adulto, adulto mayor, mujer, cardiovascular, salud mental

1. Introducción y relevancia en Salud Pública y en el EUNACOM

Los **Programas de Salud Prioritarios (PSP)** son el eje operativo mediante el cual el **Ministerio de Salud (MINSAL)** implementa sus políticas sanitarias, traduciéndolas en acciones concretas para grupos específicos de la población.

Estos programas reflejan la estructura epidemiológica del país y los desafíos demográficos, sociales y culturales que enfrenta el sistema sanitario chileno, tales como el **envejecimiento poblacional**, el **aumento de las enfermedades crónicas**, y la **persistencia de inequidades en salud**.

En el contexto del **EUNACOM**, los PSP son evaluados porque representan **competencias esenciales del médico general en Atención Primaria**, quien debe conocer sus objetivos, indicadores, actividades prioritarias, mecanismos de seguimiento y criterios de derivación.

2. Conceptos fundamentales y marco conceptual

2.1. Definición

“Los programas de salud prioritarios son estrategias nacionales que organizan las acciones sanitarias dirigidas a mejorar la salud y calidad de vida de grupos poblacionales específicos, mediante intervenciones integrales, basadas en evidencia, equidad y continuidad del cuidado.”
(MINSAL, 2020)

2.2. Marco legal y programático

- **Ley N° 19.937 de Autoridad Sanitaria (2004):** establece rectoría del MINSAL.
- **Ley N° 19.966 (GES/AUGE):** define patologías prioritarias con garantías explícitas.
- **Modelo de Atención Integral en Salud Familiar y Comunitaria (MAIS, MINSAL 2013).**
- **Política Nacional de Salud 2021–2030.**
- **Objetivos Sanitarios para la Década 2021–2030.**

2.3. Ejes de organización

Los programas se estructuran según:

1. **Etapas del ciclo vital:** niño, adolescente, adulto, adulto mayor, mujer.
 2. **Problemas prioritarios:** enfermedades cardiovasculares, salud mental, salud oral, entre otros.
 3. **Determinantes sociales y enfoque de riesgo.**
-

3. Situación epidemiológica y fundamento de los programas prioritarios

Chile enfrenta un escenario de **transición epidemiológica avanzada**, caracterizado por:

- Predominio de **enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT)** (HTA, DM2, dislipidemia).
 - Reducción de la mortalidad infantil, pero persistencia de **brechas sociales y regionales**.
 - Aumento sostenido de la esperanza de vida y **envejecimiento poblacional**.
 - Mayor visibilidad de **problemas de salud mental y suicidio adolescente**.
 - Desafíos emergentes en salud sexual, reproductiva y salud ambiental.
-

4. Principales Programas de Salud Prioritarios (MINSAL, 2023)

A continuación se describen los programas nacionales activos, su población objetivo, objetivos estratégicos, actividades principales y rol del médico general.

4.1.

Programa de Salud Infantil

a) Población objetivo

Niños y niñas de 0 a 9 años, incluyendo lactantes, preescolares y escolares.

b) Objetivos

- Asegurar un crecimiento y desarrollo integral.
- Disminuir la morbilidad y mortalidad infantil.
- Detectar precozmente trastornos del desarrollo, nutrición y maltrato.

c) Estrategias principales

- **Controles del niño sano** (PNI – pauta ministerial según edad).
- **Evaluación del desarrollo psicomotor** (EEDP y TEPSI).
- **Vacunación obligatoria** según esquema PNI.
- **Detección y manejo de malnutrición infantil.**
- **Prevención de accidentes y promoción de lactancia materna.**

d) Rol del médico general

- Supervisar crecimiento y desarrollo.
 - Detección precoz de patologías y derivación oportuna.
 - Educación a padres y cuidadores.
 - Registro y seguimiento en ficha clínica electrónica (RAYEN o SIGGES).
-

4.2.

Programa de Salud del Adolescente

a) Población objetivo

Jóvenes entre 10 y 19 años.

b) Objetivos

- Promover estilos de vida saludables y autocuidado.
- Reducir riesgos asociados a sexualidad, drogas y salud mental.
- Asegurar acceso confidencial y oportuno a atención sanitaria integral.

c) Estrategias

- **Control del adolescente sano.**
- **Educación sexual y reproductiva.**
- **Prevención del embarazo adolescente.**
- **Tamizaje de salud mental (anhedonia, ideación suicida, consumo).**
- **Espacios amigables para adolescentes (consulta confidencial).**

d) Rol del médico general

- Evaluación integral biopsicosocial.
- Consejería confidencial en sexualidad y salud mental.
- Derivación al psicólogo o psiquiatra en caso de riesgo suicida.
- Coordinación con establecimientos educativos y redes juveniles.

4.3.

Programa de Salud de la Mujer

a) Población objetivo

Mujeres en edad fértil (10–49 años) y embarazadas.

b) Objetivos

- Promover salud sexual y reproductiva.
- Reducir morbilidad y mortalidad materna.
- Prevenir cáncer cervicouterino y mamario.

c) Estrategias

- **Control prenatal integral** (al menos 7 controles).
- **Tamizaje de VPH y PAP** según norma técnica.
- **Tamizaje de cáncer de mama** (mamografía desde los 50 años).
- **Planificación familiar y anticoncepción gratuita (GES).**
- **Atención postparto y puerperio.**

d) Rol del médico general

- Control del embarazo fisiológico y detección de factores de riesgo.
 - Toma de PAP y derivación según resultados.
 - Prescripción de anticoncepción.
 - Promoción de lactancia y control postnatal.
-

4.4.

Programa de Salud del Adulto

a) Población objetivo

Personas entre 20 y 64 años.

b) Objetivos

- Disminuir prevalencia y complicaciones de enfermedades crónicas.
- Promover estilos de vida saludables.

c) Estrategias

- **Control de salud del adulto sano.**
- **Tamizaje de hipertensión, diabetes, obesidad, dislipidemia.**
- **Promoción de alimentación saludable y actividad física.**

- **Derivación al Programa Cardiovascular cuando corresponde.**

d) Rol del médico general

- Evaluar riesgos y comorbilidades.
 - Iniciar tratamientos según guías clínicas MINSAL.
 - Educación en autocuidado.
 - Registrar y seguir evolución del paciente.
-

4.5.

Programa de Salud Cardiovascular (PSCV)

a) Población objetivo

Adultos con factores de riesgo cardiovascular (HTA, DM2, dislipidemia, tabaquismo, obesidad).

b) Objetivos

- Reducir morbimortalidad por enfermedades cardiovasculares.
- Mejorar control metabólico y adherencia terapéutica.

c) Estrategias

- **Tamizaje universal desde los 15 años (APS).**
- **Ingreso de pacientes con riesgo ≥ 10 % según Framingham.**
- **Control periódico por equipo multidisciplinario.**
- **Reforzamiento de adherencia y educación sanitaria.**

d) Rol del médico general

- Diagnóstico y manejo inicial de HTA y DM2.
- Evaluación global de riesgo cardiovascular.

- Supervisión de enfermería y nutrición.
 - Derivación a nivel secundario en caso de complicaciones.
-

4.6.

Programa de Salud del Adulto Mayor

a) Población objetivo

Personas de 65 años y más.

b) Objetivos

- Favorecer envejecimiento activo y saludable.
- Prevenir dependencia y deterioro funcional.

c) Estrategias

- **Control preventivo del adulto mayor (EMPAM).**
- **Tamizaje de fragilidad y salud mental.**
- **Promoción de actividad física, autocuidado y apoyo social.**
- **Vigilancia de vacunación antigripal y antineumocócica.**

d) Rol del médico general

- Evaluación integral (biológica, funcional, cognitiva y social).
 - Identificación de dependencia incipiente.
 - Coordinación con programa domiciliario y apoyo social municipal.
-

4.7.

Programa de Salud Mental

a) Población objetivo

Toda la población, con énfasis en niños, adolescentes y adultos en riesgo.

b) Objetivos

- Promover bienestar mental y prevenir trastornos.
- Aumentar cobertura de tratamiento oportuno.
- Integrar salud mental a la atención primaria.

c) Estrategias

- **Pesquisa activa de depresión, ansiedad y riesgo suicida.**
- **Atención de trastornos leves y moderados en APS.**
- **Derivación a nivel secundario (COSAM, hospitales de día).**
- **Promoción de salud mental comunitaria y redes de apoyo.**

d) Rol del médico general

- Aplicar tamizajes (PHQ-9, GAD-7, escala de riesgo suicida).
- Iniciar tratamiento farmacológico y psicoterapia breve.
- Derivar casos graves a psiquiatría.
- Coordinar redes locales (COSAM, trabajo social, familia).

5. Enfoque transversal de los programas

Los Programas de Salud Prioritarios comparten los siguientes ejes:

1. **Ciclo vital y determinantes sociales.**
2. **Integralidad y continuidad del cuidado.**
3. **Intersectorialidad (educación, municipios, desarrollo social).**
4. **Participación comunitaria.**

5. Equidad territorial y de género.

Todos se implementan desde la **APS**, en coordinación con el nivel secundario y con supervisión técnica de los **Servicios de Salud**.

6. Rol del médico general en los Programas de Salud Prioritarios

El médico general es el **gestor clínico y articulador de los programas** en el territorio, con las siguientes responsabilidades:

1. **Ejecutar controles preventivos y tamizajes.**
 2. **Detectar factores de riesgo y aplicar intervenciones tempranas.**
 3. **Coordinar derivaciones y contrarreferencias.**
 4. **Supervisar adherencia y seguimiento longitudinal.**
 5. **Participar en comités locales de gestión y mejora continua.**
 6. **Promover acciones de educación y participación comunitaria.**
 7. **Registrar y reportar indicadores de gestión al Servicio de Salud.**
-

7. Errores comunes en EUNACOM y razonamientos errados

Error frecuente	Corrección
Creer que los programas son aislados	Son complementarios y transversales en la red asistencial.
Pensar que los controles son responsabilidad exclusiva de enfermería	El médico general tiene rol clínico y de liderazgo.

Confundir “control de salud” con “control de enfermedad”	Los controles buscan prevenir y promover, no solo tratar.
Omitir el componente comunitario	Todos los programas incluyen acciones comunitarias.
Ignorar la contrarreferencia	Es esencial para la continuidad del cuidado.
Desconocer el uso del EMPAM, EEDP o PSCV	Son herramientas ministeriales estandarizadas.

8. Normativa y documentos ministeriales vigentes

- MINSAL (2021). Política Nacional de Salud 2021–2030.
 - Guías Clínicas y Protocolos de los Programas Nacionales (2022–2023).
 - Manual de Atención Integral del Niño, Adolescente y Adulto Mayor.
 - Guía Clínica de Salud Mental Comunitaria (MINSAL, 2019).
 - Programa Nacional de Promoción de la Salud (MINSAL, 2018).
-

9. Resumen final — 5–7 ideas clave

1. Los **Programas de Salud Prioritarios** son la herramienta principal del MINSAL para operacionalizar políticas de salud en todos los niveles.
2. Se organizan según el **ciclo vital** y los principales problemas epidemiológicos del país.
3. La **APS** es su eje de implementación, asegurando integralidad, equidad y continuidad.

4. El **médico general** es el responsable de la ejecución clínica, derivación y seguimiento.
5. Programas como el **Infantil, Mujer, Cardiovascular y Salud Mental** son de alta relevancia en el EUNACOM.
6. La evaluación se basa en **indicadores de cobertura y calidad** (ej. EMPA, PAP, control prenatal, glicemia controlada).
7. Estos programas reflejan el paso del modelo curativo a uno **integral, preventivo y comunitario**.